

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Thoracentesis (Pleural Tap)

معلومات الإقرار - نسخة المري
بزل الصدر (إحداث شق في الفراغ الجنبي بالرنة لسحب السوائل)

1. What is a thoracentesis (pleural tap)?

A pleural tap removes a sample of fluid which has built up in the space between the lungs and the ribs.

If you have a closed pleural biopsy the same process is used to remove tissue samples from the inside lining of the chest wall.

You will have the following procedure:

The area where the pleural tap needle goes is numbed by an injection of local anaesthetic. The needle goes through the skin, between the ribs and into the fluid around the lung. A sample of fluid is taken and sent to pathology for testing. Sometimes the doctor is unable to obtain a sample of fluid.

At the end of the procedure, the needle is taken out. A dressing is put over the area.

A Chest X-Ray may then be taken.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **Local Anaesthetic and Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one

3. What are the risks of this specific procedure?

In recommending this procedure your doctor has balanced the benefits and risks of the procedure against the benefits and risks of not proceeding. Your doctor believes there is a net benefit to you going ahead. This is a very complicated assessment.

There are risks and complications with this investigation. They include but are not limited to the following.

Common risks and complications (more than 5%) include:

- Coughing.
- Fainting.
- Collapsed lung. This may need a chest tube to be inserted into the chest cavity to reinflate the lung.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications and thrombosis.

Uncommon risks and complications (1- 5%) include:

Fluid may build up in the lung after air or fluid is removed. You may feel short of breath.
Pain. This is more likely if you have a closed pleural biopsy. This can be controlled with pain relief medication.

Rare risks and complications (less than 1%) include:

- Bleeding into the space between the lungs and ribs. This

1. ما هو بزل الصدر (إحداث شق في الفراغ الجنبي بالرنة لسحب السوائل) ؟

يتم في إجراء بزل الصدر أخذ عينة من السوائل المتراكمة في الفراغ الجنبي (الفراغ بين الرئتين والأضلاع).

إذا كان مقررًا لك أخذ عينة مغلقة من الفراغ الجنبي ، فسوف يتم اتباع نفس الإجراء لإزالة عينة من نسيج الغشاء الداخلي المبطن لجدار الصدر. سوف تخضع للإجراء التالي:

يتم تخدير المنطقة التي ستدخل من خلالها الإبرة المستخدمة في بزل الصدر باستخدام مخدر موضعي . تدخل الإبرة عبر الجلد وبين الأضلاع إلى أن تصل للسوائل الموجودة حول الرئة . تؤخذ عينة من هذه السوائل وترسل إلى مختبر علم الأمراض لفحصها. أحياناً لا يكون بمقدور الطبيب الحصول على عينة من السوائل.

في نهاية الإجراء ، تزال الإبرة ويوضع الضماد على منطقة الإجراء. قد تلتقط صور بالأشعة السينية للصدر .

2. التخدير الذي أتلقاه

هذا الإجراء يتطلب الخضوع للتخدير.
اقرأ ورقة تعليمات التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لقد أوصى طبيبك بهذا الإجراء بعد قيامه بمقارنة وموازنة فوائد ومخاطر القيام بالإجراء مقابل فوائد ومخاطر عدم القيام به ، ويرى طبيبك أنك تحصل على فائدة أكثر بخضوعك لهذا الإجراء.

هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة (أكثر من 5%) وتشمل:

- السعال.
- حدوث إغماء.
- انهيار (انطباق) الرئة، قد يتطلب علاج ذلك إدخال أنبوب الصدر في الفراغ الصدري لإعادة نفخ الرئة.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية

مخاطر ومضاعفات غير شائعة (1-5%) وتشمل:

- تراكم السوائل في الرئة بعد سحب وإزالة السوائل أو الهواء. قد يشعر المريض بصعوبة في التنفس (ضيق النفس).
- ألم . ألم على الأرجح يشعر المريض بذلك إذا كان قد خضع لإجراء أخذ عينة مغلقة من الفراغ الجنبي. يمكن السيطرة على ذلك بتناول الأدوية المضادة للألم.

أخطار ومضاعفات نادرة الحدوث (أقل من 1%) وتشمل:

- حدوث نزيف في الفراغ بين الرئتين والأضلاع . قد يكون ذلك أكثر شيوعاً إذا

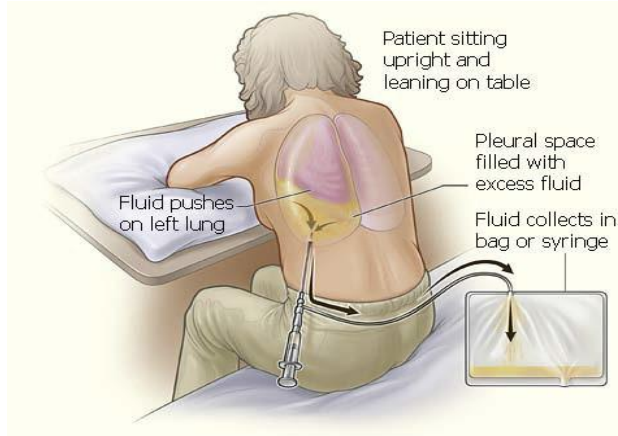
Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

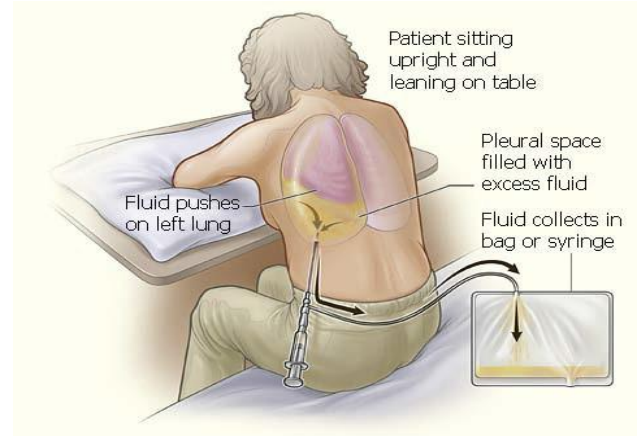
may be more common if you have a closed pleural biopsy.

- The needle may damage nearby parts of the body (for example: liver or spleen).
- Emergency surgery due to complications with the procedure.
- Death as a result of this procedure is rare.



Notes to talk to my doctor about:

- كنت قد خضعت لإجراء أخذ عينة مغلقة من الفراغ الجنبي.
- قد تسبب الإبرة ضرراً للأجزاء المجاورة من الجسد (مثل الكبد أو الطحال).
 - الحاجة لجراحة طارئة بسبب مضاعفات الإجراء.
 - الوفاة نادرة بسبب هذا الإجراء.



أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
